



Острый стресс: как проявляется и что делать в первые минуты

Речь пойдет об острых реакциях на тяжелый стресс, к которому обычно относят экстремальные ситуации: стихийные бедствия, пожары, взрывы, аварии, внезапную потерю близких, насилие. Острая шоковая реакция длится от нескольких часов до нескольких дней. Она может развиваться в двух вариантах. Расскажем об этом подробнее, а также о том, как помочь человеку в состоянии тяжелого стресса.

Итак, шоковая реакция может быть двух видов: гиперкинетическая и гипокинетическая.

Гиперкинетический вариант. Человек безостановочно мечется, совершает хаотичные движения. Это называется двигательной бурей. Будто мотылек в закрытом помещении. Такие люди могут метаться среди обломков разрушенного пожаром, взрывом или землетрясением дома, спотыкаться об обломки, падать, получать повреждения и в то же время начинать метаться снова. На вопросы и тем более на уговоры окружающих они не реагируют. После они не будут помнить этот период.

Гипокинетический вариант. Человек резко заторможен, не реагирует на окружающее, не отвечает на вопросы, как будто оглушен. На лице явное выражение страха. Состояние таких людей можно сравнить с поведением жертвы в лапах хищника. Они пассивны, не сопротивляются действиям окружающих.

Невозможно предсказать, как человек поведет себя после стресса: будет метаться или станет заторможенным. Это зависит от личностных особенностей. И такие шоковые варианты проявляются не у всех. Большей частью бывают не преувеличенные, адекватные обстоятельствам психологические реакции, то есть горе, отчаяние, гнев, растерянность. В любом случае пострадавшие нуждаются в помощи специалистов: врачей и психологов.

Что делать?

При любом варианте шоковой реакции обязательно необходима врачебная медикаментозная помощь. А значит, первое, что нужно обеспечить пострадавшему, - это помощь врача. Затем окружите человека ненавязчивой



заботой, дайте ему то, чего он хочет. Ориентируйтесь на текущие желания человека (дать ему воды, укрыть пледом).

Лучше всего - находиться рядом, то есть в шаговой доступности. Если человек открыт к общению - поддержать его, стараться задавать вопросы так, чтобы пострадавший раскрывал уже начатую тему, а не начинал новую (а лучше больше слушать), обращать внимание на самочувствие человека в данный момент, на то, что он испытывает. Если закрыт - отойти, но быть поблизости.

Ключевым вариантом помощи в данной ситуации является активное и эмпатическое слушание, предоставление возможности выговориться, поделиться проблемой. Разделяя ее с кем-то, человек облегчает собственный груз, как бы снимая с себя часть ноши. Основная задача - дать выговориться, стать для человека ресурсом сил для успешного переживания горя.

Расстройства адаптации

К сожалению, после шоковой реакции у человека могут развиваться длительные (как правило, не больше 6 месяцев) расстройства, которые говорят о том, что из-за мощного отрицательного психологического воздействия человек не может приспособиться (адаптироваться).

Например, это может быть депрессивная реакция: тоска, заторможенность, выраженная утомляемость, нарушение памяти и внимания. Такие люди продолжают переживать психотравмирующую ситуацию, она продолжает быть главным содержанием психическим переживаний.

Возможна также тревожно-депрессивная реакция, когда у человека чаще возникает не тоска, а тревога. Двигательная заторможенность сменяется приступами паники, во время которой человек мечется по комнате. В обоих случаях необходима помощь психиатра и психолога.